La spondylarthrite ankylosante

Cours reconstruit à partir de la banque de QCM : tout ce qu'il faut comprendre pour répondre aux questions, rien de superflu.

Comment lire ce cours

TOMBE EN QCM signale un point déjà posé en QCM ; le chiffre ×N indique combien de fois il apparaît dans la banque (doublons entre sessions inclus). Les étoiles donnent la priorité : ★★★ ≥ 10 questions, ★★ 5 à 9, ★ moins de 5.

✔ = proposition juste dans la banque · ✘ = proposition fausse (les pièges). Les encadrés rouges signalent les ambiguïtés ou contradictions entre la banque et le cours.

À propos du contenu

- Le cours fourni est celui de la **SA de l'adulte** (Pr Lamri). La **forme de l'enfant** n'y tient qu'en une ligne (« SpA juvéniles ») ; elle n'est jamais interrogée seule dans la banque. Une courte section « forme juvénile » (§ 9) la résume ; le contenu hors cours y est signalé comme tel.
- Banque exploitée : **63 QCM** classés « Spondylarthrites » + une quarantaine d'autres répartis dans d'autres chapitres (PR, Pott, lombalgies…) qui testent la SA.

Les 10 points à connaître avant tout

1. La SA est **séronégative** (FR/ACPA négatifs), liée à **HLA-B27** (~90 %), mais HLA-B27 n'est **ni nécessaire ni suffisant**.
2. Lésion élémentaire = **enthésite** (pas la synovite). Cible : sacro-iliaques et rachis (charnière **dorso-lombaire** d'abord).
3. Douleur **inflammatoire** : nocturne (2e moitié de nuit), raideur matinale, soulagée par **AINS**, non impulsive à la toux.
4. Périphérique : **oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs**, **talalgies**, dactylite (orteil en saucisse).
5. Extra-articulaire : **uvéite antérieure** aiguë, unilatérale, récidivante (la plus fréquente) ; insuffisance aortique ; syndrome restrictif.
6. Radio : **sacro-iliite bilatérale** (signe précoce le plus fidèle), **syndesmophytes**, squaring, bambou. Jamais d'ostéophytes ni de géodes.
7. Associations : **psoriasis, MICI** (Crohn, RCH), urétrite non gonococcique / arthrite réactionnelle.
8. Traitement : **AINS en 1re intention**, puis anti-TNF (dépister la TB). Corticoïdes généraux inefficaces. Kinésithérapie +++.
9. Risque principal = **raideur / ankylose du rachis**. Mauvais pronostic : coxite, début précoce, tabac, dactylite, syndrome inflammatoire.
10. La PR **épargne** sacro-iliaques et rachis dorso-lombaire ; la SA n'est **pas** le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent (c'est la PR).

Ce qui tombe le plus

Thème	Fréquence	Priorité
Radiologie (sacro-iliite, syndesmophytes, signes « sauf »)	≈ 15	★★★
Douleur inflammatoire / horaire nocturne	≈ 13	★★★
Oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs	≈ 13	★★★
Enthésite, talalgies	≈ 13	★★★
Manifestations extra-articulaires (uvéite +++)	≈ 11	★★★
HLA-B27 (rôle, pourcentages, utilité)	≈ 11	★★★

Thème	Fréquence	Priorité
Examen clinique (Schöber, ampliation, C7-mur)	≈ 7	★★
Traitement	≈ 6	★★
Arthrites réactionnelles / Fiessinger-Leroy-Reiter	≈ 6	★★
Diagnostic différentiel (PR vs SA, sacro-iliite bilatérale)	≈ 6	★★
Associations (psoriasis, MICI) et rhumatisme psoriasique	≈ 5	★★
Syndrome pelvi-rachidien	≈ 4	★
Pathogénie (TNF, anticorps, peptide arthritogène)	≈ 3	★
Pronostic	≈ 2	★

1 · Le concept de spondyloarthrites TOMBE EN QCM ×2 ★

Les spondyloarthrites (SpA) forment une **famille** de maladies qui partagent les mêmes caractéristiques cliniques, radiographiques et génétiques. La **spondylarthrite ankylosante (SA)** en est le « chef de file » : douleur, enraidissement puis ankylose du squelette axial.

Membres de la famille	Points communs à tous
• **Spondylarthrite ankylosante** • **Rhumatisme psoriasique** • **Arthrites réactionnelles** • **Arthrites des MICI (Crohn, RCH)** • **SpA indifférenciées** • **SpA juvéniles** • **Uvéite antérieure aiguë (associée)**	• Début précoce, adulte jeune **20–30 ans** • Lésion élémentaire : **enthésite** • Atteinte axiale et/ou périphérique • Manifestations extra-articulaires (uvéite antérieure, psoriasis…) • Terrain génétique : **HLA-B27**, antécédents familiaux • AINS = base du traitement

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×2 **Caractéristiques communes aux spondylarthrites**

- ✔ Liaison à l’antigène HLA-B27
- ✔ L’enthésite est la lésion élémentaire la plus caractéristique
- ✔ Existence d’atteinte viscérale extra-articulaire
- ✔ Les AINS constituent la base du traitement
- ✘ Touchent avec prédilection le sujet âgé

Autres items pos s : La SpA est une maladie auto-immune (vs infectieuse, m tabolique, neurologique, traumatique) ; La PR est une spondylarthrite .

2 · Épidémiologie et pathogénie TOMBE EN QCM ×3 ★

Donnée	Valeur à retenir
Prévalence	0,47 à 1,9 % de la population générale
Sexe / âge	Sex-ratio **3 hommes pour 1 femme** ; début 20–30 ans. Forme féminine : fruste.
HLA-B27 dans la SA	**≈ 90 %** (30 à 90 % selon la SpA) — fréquent chez les Indiens d’Amérique du Nord, exceptionnel chez les Noirs africains
HLA-B27 en population générale	**4 à 8 %** ; seuls 13,6 % des porteurs B27 développent une SpA
HLA-B27 dans le rhumatisme psoriasique	≈ 25 %
HLA-B27 dans les arthrites réactionnelles	35–50 % (cours) — la banque retient 75 % pour le Fiessinger-Leroy-Reiter

Mécanisme en 4 idées

- **Enthèse = cible privilégiée.** L’enthésopathie inflammatoire évolue en 3 phases : inflammation (érosions osseuses) → fibrose cicatricielle → **ossification** (enthésophyte, apposition périostée). C’est ce qui explique les images radiologiques (syndesmophytes, épines calcanéennes).
- **Synovite** : secondaire à l’enthésopathie (l’inflammation se propage de l’enthèse à la synoviale).

- **Terrain génétique** déterminant (HLA-B27) mais **insuffisant à lui seul** : il faut aussi un facteur d'environnement (mimétisme moléculaire avec des agents infectieux : Chlamydia trachomatis, Yersinia enterocolitica, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri). Modèle : rat transgénique HLA-B27.
- **Séronégative** : pas de FR ni d'ACPA, pas de forte production d'anticorps.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8 **Pathogénie et HLA-B27**

- ✔ La SA n'est **pas** le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent (PR) — la proposition inverse est fausse
- ✔ Lésion élémentaire = enthésite
- ✔ HLA-B27 : marqueur génétique des spondylarthropathies (pas de la PR, du lupus, de l'arthrose, de la goutte)
- ✔ Le diagnostic de PR n'est pas confirmé par HLA-B27 (non demandé en 1re intention dans une PR)
- ✘ « Forte production d'anticorps au cours de la SA »
- ✘ « La théorie du peptide arthritogène est la seule explication »
- ✘ « Le TNF-α est le seul médiateur de l'inflammation »
- ✘ « L'HLA-B27 est toujours positif » / « L'absence de B27 élimine le diagnostic »
- ✘ Présence de HLA-DR4 (c'est la PR)

Retenir : une SA sans B27 existe (~10 %). Le B27 oriente, il ne tranche pas.

PIÈGES

HLA-B27 en population générale. Le cours dit 4–8 % et la justification de la banque dit « environ 5 % », mais la clé de la question (95 / 50 / 25 / 5 / 0 %) marque **25 %**. Si cet énoncé exact se présente à l'examen, la valeur scientifique est ≈ 5 % ; connaissez les deux.

HLA-B27 dans le Fiessinger-Leroy-Reiter. Clé de la banque : 75 % ; le cours donne 35–50 % pour les arthrites réactionnelles. Choisir 75 % si l'énoncé parle du syndrome de Reiter typique avec ces propositions.

3 · Clinique de la SA TOMBE EN QCM ×13 ★★★

Définition : rhumatisme inflammatoire chronique avec atteinte **pelvi-rachidienne**, tendance à évoluer tardivement vers l'**ankylose**, association fréquente à une **polyenthésopathie périphérique** et forte association à HLA-B27. **Mode de début** : sacro-iliaque / rachidien dans 80 % des cas (le plus évocateur) ; articulaire périphérique 20–25 % ; enthésopathies (talalgies) ; œil rouge douloureux.

3.1 La douleur inflammatoire (le signe cardinal)

Douleur INFLAMMATOIRE (SA)	Douleur MÉCANIQUE (pas SA)
Réveille la 2e moitié de la nuit, plusieurs réveils, indépendants des changements de position	Déclenchée par l'effort ou un faux mouvement
Raideur matinale prolongée	Impulsive à la toux
Soulagée par l'exercice, pas par le repos	Calmée par le repos
Très sensible aux AINS	Dure toute la journée et se calme la nuit
Non impulsive à la toux	Évolue par crises

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×13 **Douleur rachidienne et horaire**

- ✔ Douleurs **nocturnes** lombaires ou dorsales
- ✔ La douleur **réveille le malade dans la 2e moitié de la nuit**
- ✔ Plusieurs réveils chaque nuit, en dehors de tout changement de position
- ✔ Principal signe clinique d'une SpA = douleur lombaire d'allure **inflammatoire**
- ✔ La sacro-iliite peut simuler une lombosciatique tronquée (sciatiques « à bascule »)
- ✘ Douleurs lombaires de **rythme mécanique**
- ✘ Impulsive à la toux · déclenchée par l'activité physique
- ✘ Ne répond pas aux AINS · dure toute la journée et se calme la nuit
- ✘ Raideur matinale de 15 minutes (trop courte pour être en faveur)

Un item de la banque marque aussi pr dominance vesp rale des douleurs comme juste ; retenir surtout nocturne + matinal.

3.2 Les quatre syndromes

Syndrome	Ce qu'il comprend	Examen
Pelvien (sacro-iliaque)	Douleurs fessières **uni- puis bilatérales ou à bascule**, parfois irradiées à la face postérieure de la cuisse (« sciatique tronquée », sans dépasser le genou)	Douleur des SI provoquée : pression du sacrum (**trépied**), manœuvre de **Mennell**, écartement/rapprochement des ailes iliaques
Rachidien	Rachialgie inflammatoire : lombaire et **charnière dorso-lombaire** +++, dorsale (avec douleurs thoraciques antérieures), cervicale. Enraidissement	Lombaire : distance doigts-sol, **Schöber**. Dorsal : **ampliation thoracique**, cyphose (distance C7-mur ou occiput-mur), respiration abdominale. Cervical : menton-sternum, menton-acromion, tragus-acromion
Articulaire périphérique	**Oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs** (parfois supérieurs) ; **hanche** (coxite) et épaule redoutables ; dactylite = orteil / doigt « en saucisse »	≈ 2/3 des cas au cours de l'évolution
Enthésique	**Talalgies** inflammatoires (sous- et rétro-calcanéennes, aponévrosite, tendinite achilléenne), tubérosité tibiale antérieure, grand trochanter, ischion, crêtes iliaques, olécrane, trochiter…	Douleur à la palpation et à la mise en tension (étirement / contraction résistée)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×12 **Syndrome pelvi-rachidien et signes périphériques**

- ✔ Le syndrome **pelvi-rachidien** comprend : **douleurs fessières**, **diminution de l'ampliation thoracique**, **dorso-lombalgies inflammatoires**
- ✔ SA : **oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs**, **talalgies**, iridocyclite unilatérale, douleurs fessières à bascule
- ✔ En faveur de la SA : oligoarthrite asymétrique des MI, talalgies, **orteil en saucisse**
- ✔ Tableau le plus évocateur de SpA périphérique = **oligoarthrite asymétrique des grosses articulations des MI** (genoux, chevilles)
- ✘ Talalgies et dactylite ne font **pas** partie du syndrome pelvi-rachidien (elles sont enthésique / périphérique)
- ✘ Polyarthrite bilatérale symétrique des petites articulations (= PR)
- ✘ Arthrites bilatérales poignets + IPD
- ✘ Syndrome de Raynaud · polyarthrite distale symétrique destructrice

Une variante de la banque mal cl (talalgies/dactylite coch es dans pelvi-rachidien) existe : suivre la logique anatomique ci-dessus.

3.3 Manifestations extra-articulaires

Organe	Atteinte	À retenir
Œil (≈ 30 %)	**Uvéite antérieure aiguë** (iridocyclite), non granulomateuse	Récidivante, souvent **unilatérale**, séquelles possibles (synéchies → cécité). **La plus fréquente**. Œil rouge douloureux
Cœur	**Insuffisance aortique**, troubles de conduction (BAV)	Souffle diastolique parasternal gauche : toujours le chercher (gravité)
Poumon	**Syndrome restrictif** (atteinte costo-vertébrale), fibrose des apex, syndrome interstitiel	EFR ; ↓ ampliation thoracique
Digestif	Lésions inflammatoires intestinales (colonoscopie)	Chercher Crohn / RCH devant diarrhée chronique, rectorragies
Rein	Néphropathie à IgA ; amylose	
Os	Ostéoporose, tassements vertébraux	Fracture sur rachis ankylosé = risque neurologique

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×11 **Extra-articulaire**

- ✔ Uvéite = manifestation viscérale la plus fréquente · uvéite antérieure aiguë non granulomateuse = manifestation extra-articulaire la plus fréquente
- ✔ Peuvent être constatées : **amylose, insuffisance aortique, syndrome restrictif pulmonaire**
- ✔ Antécédents en faveur : **uvéite**, **talalgies bilatérales**
- ✔ Signe clinique en faveur : **souffle diastolique** (IAo) ; sciatiques bilatérales à bascule
- ✔ Manifestations extra-articulaires d'une SpA : psoriasis, entérocolopathie inflammatoire, urétrite non gonococcique
- ✘ **Épisclérite** la plus fréquente (faux : c'est l'uvéite antérieure)
- ✘ Uvéite postérieure · choriorétinite · ostéomalacie
- ✘ Infection urinaire / respiratoire / cutanée / digestive banale
- ✘ Hépatomégalie, névrite optique, herpès labial (ne sont pas la SA)

Associations pour lesquelles on cherche chez un SpA : coloscopie + transit du gr le (Crohn, RCH).

4 · Imagerie TOMBE EN QCM ×15 ★★★

Le chapitre le plus interrogé. Principe : l'enthèse s'ossifie (§ 2) → on voit des **ponts osseux et des soudures**, jamais de géodes à l'emporte-pièce ni d'ostéophytes.

4.1 Quelles incidences ?

- **Cliché de De Sèze** (grand cliché dorso-lombo-pelvi-fémoral de face) + **rachis dorso-lombaire de profil** = les deux examens les plus utiles pour confirmer la SA.
- Bassin de face / incidence des sacro-iliaques ; centré sur la charnière dorso-lombaire ; talons ; cervical ; téléthorax.
- **TDM** et **IRM** des sacro-iliaques et du rachis : formes débutantes. Échographie des enthèses.

4.2 La sacro-iliite : stades de Forestier

Stade	Aspect radiologique
I	Élargissement et flou de l'interligne sacro-iliaque
II	Irrégularités et érosions des berges — « **timbre de poste** »
III	**Condensation** des berges
IV	**Ankylose** : fusion des berges

Typiquement **bilatérale**, parfois asymétrique. Critère NY : sacro-iliite ≥ grade 2 bilatérale ou grade 3–4 unilatérale. Signe radiologique le plus fidèle pour le diagnostic **précoce**.

4.3 Rachis, enthèses, hanches

Localisation	Signes
Rachis	**Syndesmophytes** (= enthésite rachidienne sous-ligamentaire ossifiée) → colonne en **bambou** ; **spondylite antérieure de Romanus** (érosion des angles antéro-supérieurs) ; **squaring** (mise au carré / mise en ligne du bord antérieur des corps) ; ossification des ligaments inter-épineux et inter-apophysaires (« rails de tramway ») ; ankylose des articulaires postérieures ; spondylodiscite ; ostéoporose, tassements
Siège initial	**Charnière dorso-lombaire** ; évolution ensuite ascendante
Enthèses	Épines calcanéennes postérieure et inférieure (calcanéum « hérissé »), bassin hérissé, ischion « barbu »
Hanches (coxite)	Pincement global de l'interligne ; formes érosive (géodes sous-chondrales), ankylosante, synostosante

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×15 **Signes radiologiques**

- ✔ **Syndesmophytes** · ossification des ligaments intervertébraux · ankylose des sacro-iliaques · irrégularités d'une sacro-iliaque
- ✔ Mise au carré des vertèbres (squaring) · mise en ligne du bord antérieur des corps lombaires
- ✔ Spondylite érosive de Romanus · ossifications ligamentaires · arthrite inter-apophysaire postérieure · ossification des ligaments jaunes · épines calcanéennes
- ✔ Signe radiologique le plus précoce / fidèle = **altération bilatérale des interlignes sacro-iliaques**
- ✔ Premiers signes rachidiens = **charnière dorso-lombaire**
- ✔ Syndesmophyte = signe le plus caractéristique de la SA ; pas « dégénérescence du disque »
- ✘ **Ostéophytes** (arthrose, base large dirigée en dehors) — « sauf un »
- ✘ **Géodes à l'emporte-pièce** (goutte) · géode intra-somatique
- ✘ **Vertèbre ivoire** (clé de la banque : non évocatrice de SA ; elle fait discuter métastase prostatique, Hodgkin, Paget)
- ✘ Fractures vertébrales · pincement de plusieurs disques lombaires · bloc vertébral (isolé)
- ✘ Syndesmophytes « exclusivement lombaires » (faux : dorso-lombaires)

Variante de la banque : Sacro-iliite stade II = pincement irr gulier + condensation des berges marqu e juste, alors que le cours place la condensation au stade III. La banque signale elle-m me cet item comme quivoque (deux classifications).

5 · Évaluation clinique et biologie TOMBE EN QCM ×7 ★★

Mesure	Ce qu'elle explore	Valeur
Indice de Schöber	Flexion du rachis **lombaire** et de la charnière lombo-sacrée ; patient penché en avant ; repères : ligne bi-iliaque + ligne des épineuses	Normale : **10 + 5 cm** (de 10 à ≥ 15). Peut varier dans la journée (maximum de raideur le matin). Pas toujours pathologique dans la SA.
Ampliation thoracique	Atteinte costo-vertébrale	Pathologique si faible (3,5 cm dans un cas de la banque = pathologique)
C7-mur / occiput-mur	Cyphose dorsale	Normale = 0 ; 10 cm = pathologique ; 8 → 12 cm sur 1 an = aggravation
Distance doigts-sol	Mobilité lombaire globale	

Biologie

- Syndrome inflammatoire **inconstant** (VS, CRP, anémie). Bilan de la banque : VS 48 mm dans un cas typique ; VS 10 mm dans un autre : la SA ne dépend pas de la VS.
- **Tests de la PR négatifs** (FR, ACPA) : le FR ne se retrouve pas dans la SA.
- **HLA-B27** ≈ 90 % : utile pour les cas douteux, au stade de début. **Non demandé de façon systématique** et jamais indispensable devant un tableau évident.
- Liquide synovial : inflammatoire. Ponction-biopsie sacro-iliaque : seulement si doute avec une sacro-iliite infectieuse.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×9 **Examen clinique et biologie**

- ✔ Schöber : explore la flexion du rachis lombaire et lombo-sacré ; peut varier dans la journée
- ✔ Schöber : se mesure patient penché en avant, avec repère ligne des épineuses / ligne bi-iliaque
- ✔ Ampliation thoracique de 3,5 cm = pathologique, atteinte costo-vertébrale
- ✔ Distance occiput-mur de 10 cm = pathologique
- ✔ Pour affirmer la SA : **les données cliniques et radiographiques suffisent**
- ✘ Schöber « toujours pathologique dans la SA » · « toujours normal dans les lombalgies communes »
- ✘ Schöber nécessite le repère de L1 / explore le rachis dorsal / est inférieur à 10 cm chez le sujet normal
- ✘ B27 indispensable · scintigraphie nécessaire · AAN et hypocomplémentémie « décisifs » · PBR sacro-iliaque systématique
- ✘ FR ou FAN : sans intérêt pour la SA (le FAN est demandé dans la PR)

Bilan de 1 intention d une PR : NFS-VS-CRP, FR, ACPA, FAN. HLA-B27 n en fait pas partie.

6 · Diagnostic TOMBE EN QCM ×5 ★★

Critères	Pour quoi ?	Contenu
Amor / ESSG	SpA en général	
New York modifiés (1984)	**SA**	**Clinique** : lombalgie + raideur > 3 mois améliorée par l'exercice, non par le repos ; limitation de la mobilité lombaire (sagittal et frontal) ; limitation de l'ampliation thoracique. **Radiologique** : sacro-iliite grade ≥ 2 bilatérale ou 3–4 unilatérale. SA avérée = critère radiologique + ≥ 1 critère clinique
ASAS axial (2009)	SpA axiale (y compris **non radiographique**)	Rachialgies ≥ 3 mois, début < 45 ans : **sacro-iliite en imagerie + ≥ 1 critère SpA** OU **HLA-B27 + ≥ 2 critères SpA**
ASAS périphérique	SpA périphérique	Arthrite ou enthésite ou dactylite **+** (≥ 1 : uvéite, psoriasis, Crohn/RCH, infection préalable, HLA-B27, sacro-iliite) OU (≥ 2 : arthrite, enthésite, dactylite, rachialgie inflammatoire, ATCD familial)

Critères de SpA (ASAS) : rachialgie inflammatoire · arthrite · enthésite (talon) · uvéite · dactylite · psoriasis · Crohn/RCH · bonne réponse aux AINS · ATCD familial de SpA · HLA-B27 · CRP élevée.

Diagnostic différentiel

Situation	À évoquer / éliminer
Formes débutantes	Autres rhumatismes inflammatoires : IRM des SI et du rachis, HLA-B27
Sacro-iliite unilatérale	Sacro-iliite **infectieuse** (tuberculose, brucellose) : ponction-biopsie de la SI
Sacro-iliite bilatérale	Ostéose iliaque condensante (condensation triangulaire du versant iliaque) · SI normales de l'adolescent · arthrose des SI du sujet âgé (ostéophytes). La banque ajoute : brucellose, sarcoïdose, hémochromatose, arthropathies microcristallines
Syndesmophytes	Arthrose (ostéophytes à base large, dirigés en dehors) · **hyperostose vertébrale ankylosante de Forestier** (sujet âgé, diabétique, ponts osseux antéro-latéraux droits, disques normaux, souvent asymptomatique)
Sciatique	Hernie discale, Pott L5-S1, spondylodiscite des SpA, myélome : la sciatique « à bascule » du sujet jeune doit faire penser à la SA
Monoarthrite révélatrice d'une PR	Premier diagnostic différentiel = **infection** (pas la SpA)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×6 **PR ou SA ?**

- ✔ PR : symétrique, **acromélique**, épargne les **sacro-iliaques**, le rachis dorsal et lombaire et les IPD ; FR positif ~75 % à 1 an
- ✔ PR = le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent ; maladie systémique auto-immune
- ✔ TDM des sacro-iliaques : pas justifiée d'emblée dans une PR récente
- ✔ Sacroiliite bilatérale possible dans : brucellose, SA, sarcoïdose, hémochromatose, arthropathies microcristallines
- ✘ PR = spondylarthrite · la PR touche l'homme jeune · début juvénile très fréquent
- ✘ SA = hyperuricémie (non : IRC, hémopathies, psoriasis étendu en sont responsables)
- ✘ Un FR positif ne se voit pas dans la SA

7 · Les autres spondyloarthrites TOMBE EN QCM ×11 ★★★

	Rhumatisme psoriasique	Entérocolopathies	Arthrite réactionnelle (Fiessinger-Leroy-Reiter)
Contexte	Psoriasis = 2 % de la population ; 5–7 % font un rhumatisme. L'atteinte articulaire précède le psoriasis dans 5–10 % des cas	Crohn et RCH : 10–20 % de manifestations rhumatologiques	Arthrite **aseptique** déclenchée par une infection à distance (sexuelle ou digestive)
Clinique	Oligoarthrite asymétrique (70 %) ; polyarthrite asymétrique (15–20 %) ; atteinte axiale ; **IPD** ; arthrite mutilante ; dactylite	Arthrites des MI **rythmées par la poussée digestive** ; SA rare, évoluant **indépendamment** de la maladie digestive ; sacro-iliite isolée	Oligoarthrite asymétrique des MI < 1 mois après urétrite ou diarrhée ; conjonctivite, iridocyclite ; balanite, érosion du palais, **kératodermie palmo-plantaire**
Germes	—	—	**Chlamydiae +++**, mycoplasme (urétrites et cervicites non gonococciques) ; Shigella, Yersinia, Salmonella, Campylobacter (digestif)
Biologie	FR absent ; HLA-B27 ≈ 25 %		Identifier le germe (sérologie, **immunofluorescence** du prélèvement urétral) ; liquide articulaire **stérile** ; HLA-B27 35–50 % (cours) / 75 % (banque) ; radio normale
Évolution			⅓ guérison en 1–6 mois · ⅓ récidives · ⅓ chronicité (évolution vers une SA surtout si B27+)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×5 **Rhumatisme psoriasique et MICI**

- ✔ **Rhumatisme psoriasique** : plus d'hommes que dans la PR ; IPD souvent atteintes ; atteinte du rachis possible ; FR généralement absent
- ✔ Associées à une SpA : **psoriasis** et **rectocolite ulcéro-hémorragique** (et Crohn)
- ✘ Arthrite juvénile idiopathique et conjonctivite cochées comme « affections associées à une SpA » dans les QCM de la banque : fausses

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×6 **Fiessinger-Leroy-Reiter (arthrite réactionnelle)**

- ✔ Atteinte articulaire : membres inférieurs, **asymétrique**, parfois orteils « en saucisse », rarement vers une polyarthrite destructrice, parfois douleurs fessières
- ✔ Éléments en faveur : **conjonctivite**, **balanite** · Complications : séquelles d'uvéite, kératodermie palmo-plantaire, calcanéite, évolution vers la SA
- ✔ Preuve de Chlamydia : **sérologie anti-Chlamydia + immunofluorescence** du prélèvement urétral
- ✔ Adulte jeune ; peut évoluer vers la SA
- ✘ Culture du prélèvement urétral, hémoculture, culture du liquide articulaire (le liquide est aseptique)
- ✘ Arthropathie destructrice (le pronostic est dominé par les récidives)
- ✘ Éruption, splénomégalie, adénopathies (pas évocatrices)
- ✘ Pénicilline : inefficace (arthrite aseptique, foyer souvent déjà guéri)

Pi ge banque : l item s accompagne parfois de conjonctivite est coch faux dans une question g n rale, mais juste dans la question sur le Reiter. La conjonctivite fait bien partie du syndrome.

8 · Évolution, pronostic et traitement TOMBE EN QCM ×8 ★★

Évolution : progressive sur des années, par **poussées et rémissions**, mode ascendant. Trois étapes :

Étape	Douleurs	Raideur
Initiale	+++	+
Extension	+++	++
Ankylose	↓	+++

Principal risque = la **raideur du rachis** (ni l'infection, ni l'atteinte nerveuse, ni la pseudarthrose). **Mauvais pronostic** : début précoce, mode de début, **coxite**, syndrome inflammatoire, mauvaise réponse aux AINS ; la banque ajoute **tabagisme actif** et **dactylite**. Une bonne réponse aux AINS et un début tardif (> 16 ans) ne sont **pas** des facteurs de mauvais pronostic.

Évaluation : activité = **BASDAI, ASDAS** ; fonction = **BASFI** ; douleur = EVA ; mobilité = **BASMI** ; articulations = NAD/NAG ; inflammation = VS, CRP. **ASDAS** : < 1,3 inactive · 1,3–2,1 modérée · 2,1–3,5 élevée · > 3,5 très élevée.

Traitement

Moyen	Place dans la SA
AINS	**1re intention, effet spectaculaire** ; dose efficace, bien répartie, contre-indications respectées. Si antécédent d'ulcère : nouvelle fibroscopie gastro-duodénale avant de prescrire
Anti-TNF-α	Forme axiale après échec des AINS ; **dépistage de la tuberculose** obligatoire
Traitement de fond classique	Salazopyrine ± méthotrexate : le cours les cite ; dans la banque, le **méthotrexate est faux** pour la forme axiale (SZP utile surtout en forme périphérique)
Corticoïdes	**Peu ou pas efficaces par voie générale** ; bolus faux. **Infiltration** locale (genou) ou synoviorthèse : oui
Autres	Antipaludéens, sels d'or, D-pénicillamine : **non**. Antalgiques : adjuvants
Kinésithérapie +++	Prévenir les déformations : coucher à plat dos, **postures à plat ventre**, gymnastique respiratoire, gymnastique intensive pluriquotidienne (rachis dorsal en rectitude, lombaire en lordose)
Chirurgie	Prothèse totale de hanche (coxite évoluée) ; ostéotomie vertébrale (grande cyphose irréductible)

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×6 **Traitement**

- ✔ AINS = traitement habituellement le plus efficace ; forme axiale : **AINS + anti-TNF-α**
- ✔ Genou en poussée : **AINS adaptés + infiltration cortisonique**
- ✔ Aggravation de cyphose : **postures à plat ventre** + gymnastique intensive
- ✔ Fibroscopie avant AINS si ulcère connu
- ✔ Ostéotomie / PTH en cas de séquelles
- ✘ Corticothérapie générale · bolus de corticoïdes · antimalariques (Plaquénil) · sels d'or · D-pénicillamine
- ✘ Méthotrexate dans la forme axiale
- ✘ Collier cervical · corset plâtré de Swaim après chute avec douleur mécanique

À NUANCER

Corset de Swaim. Le cours le cite « en cas de cyphose récemment installée » ; la banque le coche faux dans un cas de douleur mécanique après chute (tassement possible). Retenir : le traitement de base de la déformation = postures et kinésithérapie ; le corset n'est pas un réflexe.

Fracture sur rachis ankylosé : peut entraîner des complications neurologiques (l'item « jamais » est faux).

9 · Forme de l'enfant (SpA juvéniles)

Ce que dit le cours : une seule ligne (« Formes selon l'âge : forme de l'enfant = SpA juvéniles ; forme du sujet > 50 ans = SpA à révélation tardive »), et « sacro-iliaques normales chez l'adolescent » dans le diagnostic différentiel d'une sacro-iliite bilatérale.

Ce que dit la banque : aucun QCM dédié à l'enfant. Utile à savoir : **début précoce = facteur de mauvais pronostic** ; l'arthrite juvénile idiopathique n'est pas une SpA (item faux) ; la **coxite** engage le pronostic fonctionnel ; boiterie de l'enfant : ne pas chercher HLA-B27 en priorité (scintigraphie d'abord).

Complément hors cours (connaissances générales, à lire pour comprendre, non issu de vos documents)

- Forme juvénile : surtout **garçon**, début vers 8–15 ans, **HLA-B27** très fréquent.
- Début souvent **périphérique** : oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs (hanche, genou, cheville) et **enthésites** (talalgies, tarse), l'atteinte axiale venant plus tard.
- On parle aussi d'« arthrite liée à l'enthésite » ; ne pas la confondre avec l'AJI oligo- ou polyarticulaire, séronégative pour le B27 et sans enthésite.

- Surveillance de l’uvéite antérieure aiguë, même chez l’enfant.

10 · Fiche flash : vrai ou faux ?

Affirmation	Réponse
La SA est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent.	FAUX (PR)
Elle touche surtout l’homme jeune (3 H pour 1 F).	VRAI
La lésion élémentaire est la synovite.	FAUX (enthésite)
Le FR et les ACPA sont négatifs.	VRAI
HLA-B27 est positif dans ≈ 90 % des SA.	VRAI
L’absence de HLA-B27 élimine le diagnostic de SA.	FAUX
La douleur lombaire de la SA est de rythme mécanique.	FAUX (inflammatoire)
Elle réveille dans la 2e moitié de la nuit et cède aux AINS.	VRAI
Les premiers signes rachidiens siègent à la charnière dorso-lombaire.	VRAI
La sacro-iliite est typiquement bilatérale.	VRAI
Les ostéophytes sont évocateurs de SA.	FAUX (syndesmophytes)
Le squaring et les rails de tramway sont des signes de SA.	VRAI
L’atteinte oculaire la plus fréquente est l’épisclérite.	FAUX (uvéite antérieure)
Une insuffisance aortique et un syndrome restrictif peuvent survenir.	VRAI
Le traitement de 1re ligne est la corticothérapie générale.	FAUX (AINS)
Les anti-TNF imposent de dépister la tuberculose.	VRAI
La PR épargne les sacro-iliaques.	VRAI
Le rhumatisme psoriasique touche volontiers les IPD, le FR est absent.	VRAI
Dans un Reiter, le liquide articulaire contient le germe en culture.	FAUX (aseptique)
La coxite est un facteur de mauvais pronostic.	VRAI
Le Schöber normal est 10 + 5 cm.	VRAI